

BRUE — ESTRATIFICAR BAIXO vs ALTO RISCO

DEFINIÇÃO DE BRUE

Aspecto	Detalhe
O que é BRUE	Brief Resolved Unexplained Event: episódio breve (< 1 min), já resolvido, em lactente < 1 ano, sem explicação após anamnese e exame
Componentes	Um ou mais: cianose/palidez; ausência/irregularidade ou diminuição da respiração; alteração do tônus (hiper ou hipotonia); alteração da responsividade
Substitui o termo	Antigo ALTE (apparent life-threatening event)
Pré-requisito	O lactente está ASSINTOMÁTICO e com exame NORMAL no momento da avaliação
Se há explicação	NÃO é BRUE — investigar/tratar a causa (refluxo, infecção, convulsão, etc.)
Apneia patológica	Pausa > 20s OU pausa mais curta com cianose/bradicardia/hipotonia

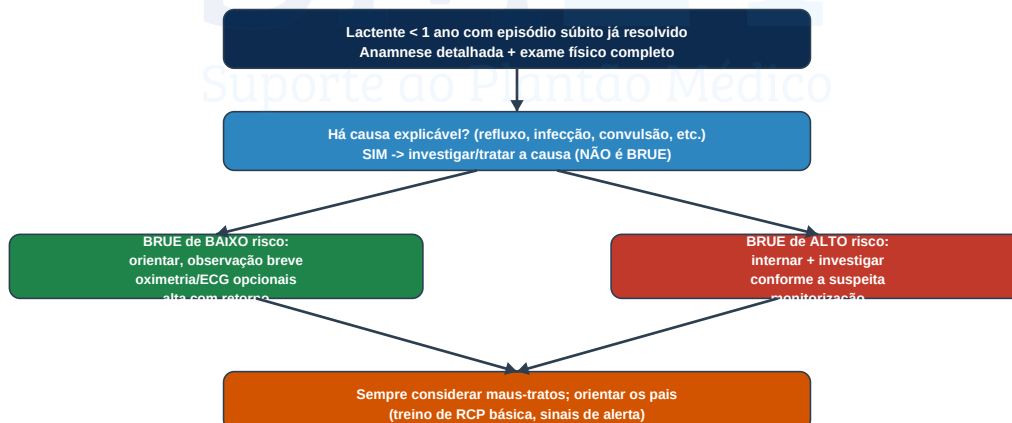
ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO (BAIXO vs ALTO)

BRUE DE BAIXO RISCO PODE TER ALTA — ALTO RISCO INVESTIGA

- BAIXO RISCO (todos): idade > 60 dias; nascido $\geq$ 32 semanas e idade gestacional corrigida $\geq$ 45 semanas; primeiro evento; duração < 1 min; sem RCP por profissional; sem achados preocupantes na anamnese/exame
- BRUE de baixo risco: não exige exames extensos nem internação de rotina — orientar, observação breve, considerar oximetria/ECG e compartilhar a decisão com a família
- ALTO RISCO: idade < 60 dias, prematuridade, evento prolongado/recorrente, necessidade de RCP, ou achados anormais
- BRUE de alto risco: internar e investigar conforme a suspeita
- Sempre considerar e afastar MAUS-TRATOS (trauma não acidental) — sinais incompatíveis, eventos repetidos
- Não 'medicalizar' o BRUE de baixo risco com exames desnecessários

ABORDAGEM DO EVENTO NO LACTENTE

EVENTO RESOLVIDO -> É BRUE? RISCO?



CAUSAS A CONSIDERAR (QUANDO HÁ EXPLICAÇÃO)

Sistema	Causas
Gastrointestinal	Refluxo gastroesofágico (causa frequente), engasgo
Respiratório	Infecção (VSR, coqueluche), aspiração, obstrução de via aérea
Neurológico	Convulsão, apneia central
Cardíaco	Arritmia (QT longo), cardiopatia
Infeccioso/metabólico	Sepse, distúrbios metabólicos, hipoglicemia
Não accidental	Maus-tratos (sufocação) — investigar sinais incompatíveis

INVESTIGAÇÃO E ORIENTAÇÕES

Alto Risco — Investigar

- Monitorização cardiorrespiratória e oximetria
- ECG (excluir QT longo / arritmia)
- Exames direcionados pela suspeita (glicemia, eletrólitos, hemograma, infecção)
- Considerar coqueluche (lactente jovem), VSR e sepsse
- Avaliar convulsão (EEG/imagem) se indicado
- Investigar maus-tratos quando houver suspeita

Baixo Risco — Orientar

- Compartilhar a decisão com a família (incerteza e baixo risco de recorrência grave)
- Observação breve no serviço (oximetria seriada)
- Não internar nem fazer bateria de exames de rotina
- Orientar sinais de alerta para retorno
- Oferecer treinamento de RCP básica aos pais
- Posição supina para dormir (prevenção de morte súbita)

CONDUTA NO PS

PONTOS-CHAVE

- ☐ Anamnese detalhada + exame completo: o lactente deve estar assintomático e normal para ser BRUE
- ☐ Se há causa explicável, NÃO é BRUE — investigar e tratar a causa
- ☐ Estratificar baixo vs alto risco (idade, prematuridade, duração, RCP, achados)
- ☐ Baixo risco: orientar, observação breve, sem exames/internação de rotina
- ☐ Alto risco: internar, monitorizar e investigar conforme a suspeita
- ☐ Sempre considerar maus-tratos e orientar os pais (RCP, posição supina, sinais de alerta)

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

SBP / Adaptada

Lactente de 4 meses, nascido a termo, com episódio único de cianose de 20 segundos que resolveu espontaneamente, agora assintomático e com exame normal. Sem RCP. Qual a conduta?

- A) Internação e bateria completa de exames
- B) BRUE de baixo risco — orientar, observação breve, exames de rotina não são necessários, alta com retorno
- C) Iniciar anticonvulsivante empírico
- D) Antibiótico de amplo espectro
- E) Cirurgia antirrefluxo

QUESTÃO 2

SBP / Adaptada

Qual característica classifica um BRUE como de ALTO risco?

- A) Idade maior que 60 dias
- B) Idade menor que 60 dias, prematuridade, evento prolongado/recorrente ou necessidade de RCP
- C) Primeiro episódio breve
- D) Exame físico normal
- E) Nascimento a termo

QUESTÃO 3

FMUSP / Adaptada

Durante a avaliação de um possível BRUE, identifica-se que o evento foi causado por refluxo gastroesofágico evidente. Qual a implicação?

- A) Continua sendo classificado como BRUE
- B) NÃO é BRUE (há causa explicável) — deve-se investigar/tratar a causa identificada
- C) Indica internação em UTI obrigatória
- D) Exige RCP imediata
- E) Define maus-tratos

QUESTÃO 4

AMRIGS / Adaptada

O que NÃO deve faltar na avaliação de um evento no lactente, mesmo sem sinais evidentes?

- A) Tomografia de crânio de rotina
- B) Considerar a possibilidade de maus-tratos (trauma não acidental)
- C) Antibiótico empírico para todos
- D) Internação obrigatória de todos
- E) Eletroencefalograma de rotina

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Qual orientação de prevenção deve ser dada aos pais de um lactente após um BRUE de baixo risco?

- A) Colocar o bebê para dormir em decúbito ventral
- B) Posição supina para dormir e oferecer treinamento de RCP básica, com sinais de alerta para retorno
- C) Suspender o aleitamento materno
- D) Manter o bebê monitorizado em casa com aparelho hospitalar
- E) Restringir as vacinas

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Lactente > 60 dias, a termo, primeiro evento breve (< 1 min), sem RCP, assintomático e com exame normal = BRUE de BAIXO risco. A conduta é orientar e fazer observação breve, sem internação nem exames extensos de rotina, compartilhando a decisão com a família.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

BRUE de alto risco: idade < 60 dias, prematuridade (< 32 semanas / idade corrigida < 45 semanas), evento prolongado ou recorrente, necessidade de RCP por profissional, ou achados anormais na anamnese/exame. Esses exigem internação e investigação.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Por definição, BRUE é um evento INEXPLICADO. Se há uma causa identificável (como refluxo evidente), NÃO se trata de BRUE — deve-se investigar e tratar a causa específica encontrada.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Em todo evento no lactente, deve-se sempre considerar a possibilidade de maus-tratos (trauma não accidental/sufocação), especialmente quando a história é incompatível ou há eventos repetidos. Exames de rotina como TC/EEG não são indicados para todos.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Após BRUE de baixo risco, orienta-se a posição supina para dormir (prevenção de morte súbita do lactente) e oferece-se treinamento de RCP básica aos pais, com orientação dos sinais de alerta para retorno ao serviço.

SM24
Suporte ao Plantão Médico